



UNM HEALTH SCIENCES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ALBUQUERQUE

University of New Mexico Hospital - Obstetric Department

N° Dossier : UNM-2002-8841

Date de l'intervention : 14 mars 2002 | Heure : 03:42 AM

Classification : Urgence Vitale Absolue / Profil Hématologique Critique



IDENTIFICATION DE LA PATIENTE

- Nom / Prénom : YOUNG Margot
- Date de naissance : 09/09/1980 (21 ans)
- Terrain pathologique connu : Maladie de Willebrand (VWD) de Type 3 (*Déficit total en VWF / Effondrement du Facteur VIII*)



ÉQUIPE OPÉRATOIRE

- Chirurgien Principal : Dr. J. Carter (Chirurgie Gynécologique)
- Anesthésiste-Réanimateur : Dr. L. Cruz (Département d'Anesthésie-Réanimation)

1. CONTEXTE CLINIQUE & CAUSE À EFFET (PATHOLOGIE)

Patient primipare de 21 ans, atteinte d'une **maladie de Willebrand de type 3**, admise en urgence absolue à 26 semaines d'aménorrhée (6 mois de grossesse) pour travail prématuré spontané et métrorragies abondantes.

Le diagnostic initial suspectait un hématome rétroplacentaire (HRP). La pathologie de base de la patiente (absence totale de coagulation primaire) a drastiquement aggravé le décollement placentaire, transformant la situation en un syndrome hémorragique foudroyant dès l'entrée en salle de travail.

2. DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

L'accouchement s'est déroulé par voie basse en urgence extrême sous protocole hémostatique lourd.

- Nouveau-né : Sexe masculin.

- **Poids** : 920 grammes.
- **État néonatal** : Score d'Apgar faible (3/5/7). Détresse respiratoire immédiate et défaillance cardiaque sévère (cardiopathie congénitale sous-jacente fortement aggravée par la grande prématurité). Transfert immédiat en unité de réanimation néonatale. Pronostic cardio-pulmonaire hautement réservé.

3. COMPLICATIONS MATERNELLES & INTERVENTION CHIRURGICALE

Immédiatement après la délivrance, la patiente a présenté une **Hémorragie du Post-Partum (HPP) massive, incoercible et foudroyante**. En raison de la maladie de Willebrand de type 3, la cascade de coagulation était inexistante : l'hémorragie n'a **pas répondu aux utérotoniques standards** (inefficacité de l'ocytocine face au défaut constitutionnel de facteurs).

Évènements per-opératoires & Réanimation :

- **Instabilité hémodynamique** : Choc hémorragique hypovolémique sévère. Entraînement d'un **premier arrêt cardio-respiratoire (ACR) d'une durée de 4 minutes**. Récupération de l'activité cardiaque après massage cardiaque externe (MCE) et injection d'adrénaline.
- **Décision chirurgicale** : Ouverture par laparotomie d'urgence pour hémostase chirurgicale. Constat per-opératoire d'une atonie utérine majeure associée à une nécrose partielle et diffuse du tissu myométrial.
- **Second arrêt cardiaque** : Nouveau collapsus cardiovasculaire durant l'acte chirurgical (**durée : 2 minutes**). Stabilisation extrêmement difficile, obtenue par une stratégie de **transfusion massive** : administration de culots globulaires, de plasma frais congelé (PFC) et perfusion massive de *concentrés de Facteur de Willebrand et de Facteur VIII plasmatiques* pour corriger le déficit constitutionnel.
- **Geste technique (Préservation fonctionnelle)** : Compte tenu du jeune âge de la patiente (21 ans), une hystérectomie totale a été écartée afin de préserver une fonction hormonale résiduelle. Réalisation d'une **hystérectomie subtotale reconstructrice** : ablation de la moitié supérieure de l'utérus (corps et fond utérin nécrosés). Le col utérin ainsi que la partie inférieure de l'isthme ont été conservés et suturés.

4. CONCLUSIONS & SUITES POST-OPÉRATOIRES

- **Hémostase chirurgicale** : Validée et obtenue après suture anatomique et ligature bilatérale des artères utérines.
- **Pronostic maternel** : Survie qualifiée de miraculeuse au vu du double ACR et du terrain hématologique (Type 3). Patiente transférée et maintenue en réanimation

lourde pour une surveillance continue de 48 heures (suivi des bilans de coagulation et de la fonction rénale).

- **Contre-indication formelle et définitive** : L'intégrité structurelle de l'utérus résiduel (isthme et col uniquement) est médicalement insuffisante pour supporter une quelconque distension gravidique. **Toute nouvelle grossesse est strictement interdite** : elle entraînerait une rupture utérine spontanée, létale de manière immédiate pour la mère. Une contraception définitive non hormonale (ou chirurgicale) et un suivi gynécologique et hématologique rigoureux sont impératifs dès sa sortie de l'établissement.



VALIDATION DU COMPTE-RENDU

Médecins en charge :

Dr. J. Carter

Dr. L. Cruz

Chirurgie Gynécologique

Anesthésiste-Réanimateur